PROTOCOLLO 51

Rilascio dei muscoli sopraioidei

Ridurre la tensione nella regione sottomandibolare

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con tensione sopraioidea	5 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Sensazione di tensione sotto il mento
- ✓ Disagio in deglutizione
- ✓ Postura con capo in avanti

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima
- ! Linfonodi aumentati o tumefazioni del collo

Posizionamento

Paziente: supino, capo neutro.

Fisioterapista: di lato al paziente, polpastrelli sotto la mandibola.

Esecuzione passo dopo passo



Contatto

Polpastrelli sotto il corpo mandibolare, lontano dalla trachea.



Pressione

Pressione verso l'alto molto delicata.



Deglutizione

Chiedi di deglutire lentamente mantenendo il contatto.



Rilascio

Mantieni fino a percepire il rilassamento.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	60 secondi
Ripetizioni	2 o 3
Pressione	minima

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Lavora con estrema delicatezza
- ✓ Rimani lateralmente rispetto alla linea mediana
- ✓ Usa la deglutizione come attivazione

Errori da evitare

- ! Pressione sulla trachea o sulla carotide
- ! Forza eccessiva
- ! Trattare in presenza di linfonodi aumentati

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Deglutizione con lingua al palato	Deglutire lentamente con lingua al palato	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** I sopraioidei collegano mandibola e osso ioide: la loro tensione influenza postura linguale e cervicale.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.